

EXPERIÊNCIA PRÁTICA · NEXT DADOS

Observatório de Saúde do Trabalhador

Projeto Integrador

EQUIPE

Gabriel Araújo

Gabriel Caminha

Guilherme Melo

Guilherme Santana

Lia Marinho

Lucas Pedro

Matheus Henrique

Robertha Miranda

MENTORES

Diógenes Cruz

Andrei Lima



dados que aproximam decisões



Secretaria de
Saúde

CONTEXTO · O PROBLEMA

A VISAT não tem diagnóstico claro e atualizado do trabalhador recifense.



HOJE

Dados fragmentados

Relatórios pontuais, sob demanda



FALTA

Acompanhamento contínuo

A dinamicidade de um observatório



EFEITO

Prioridades incertas

Inspeções e políticas sem foco territorial

SOLUÇÃO · COMO FUNCIONA

Do dado público à decisão.



ETAPA 1

Fontes

CAT, RAIS e SINAN,
dados abertos



ETAPA 2

Banco

PostgreSQL, base única
e organizada



ETAPA 3

Pipeline

Python: coleta,
transformação e carga



ETAPA 4

Dashboard

Taxas por ocupação
profissional e acidentes
de trabalho

Prioridade por **taxa**, não por contagem: toda taxa deixa claro sobre **qual total foi calculada**.

PERGUNTAS · O QUE QUEREMOS RESPONDER

Quatro perguntas guiam a análise.

1

SETORES · CNAE

Quais setores concentram mais acidentes e adoecimentos?

Em taxa, por trabalhador formal, e a evolução em três anos.

2

CBO · CID-10

Quais ocupações e diagnósticos dominam as CATs?

E como essa composição mudou do primeiro ao último ano.

3

SUBNOTIFICAÇÃO

Onde há muito vínculo formal e pouca notificação?

Sinal de subnotificação, não de segurança.

4

REDE DE SAÚDE

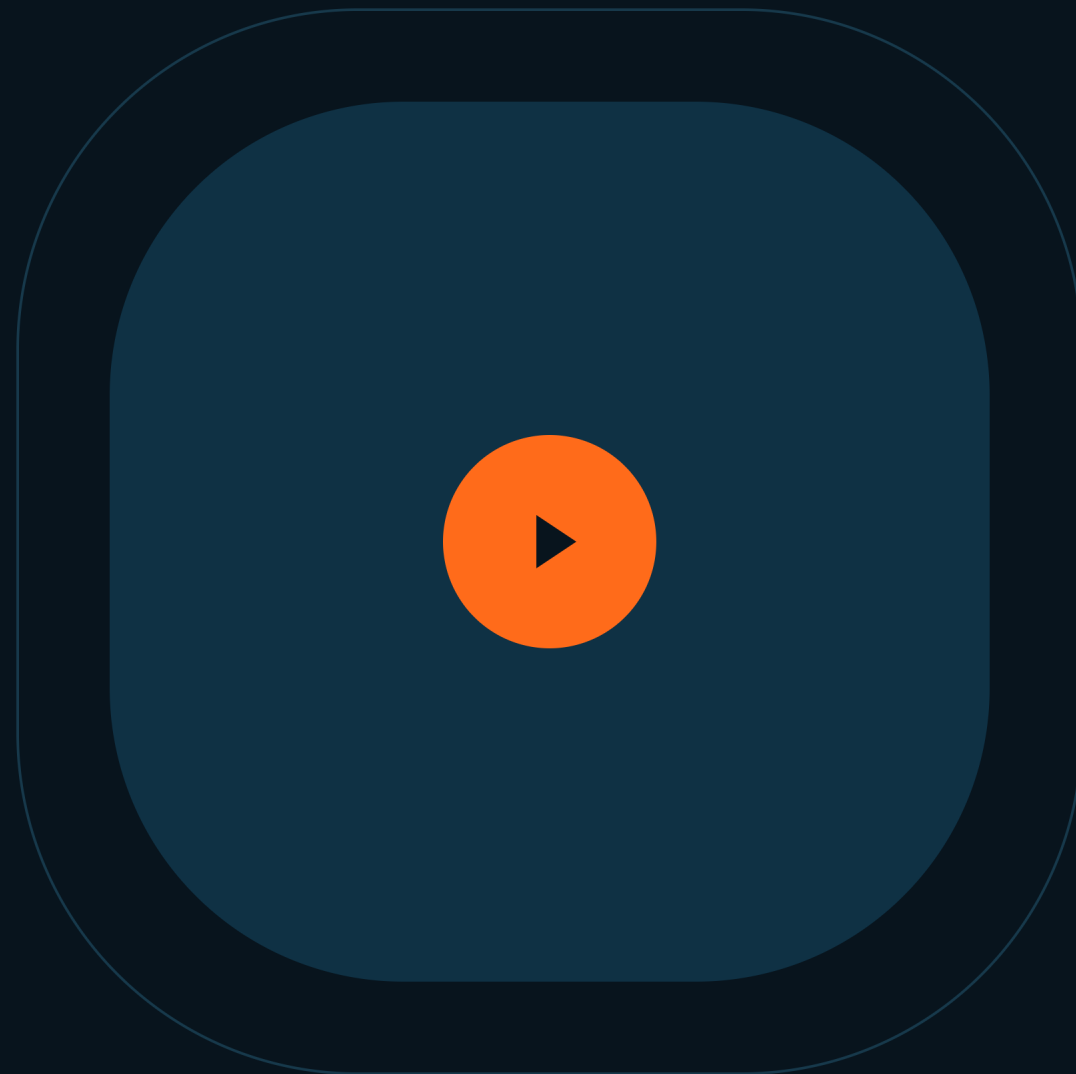
A procura pela rede acompanha o trabalho formal?

Ou aponta para o trabalho informal?

DEMONSTRAÇÃO · AO VIVO

Hora de ver ao vivo.

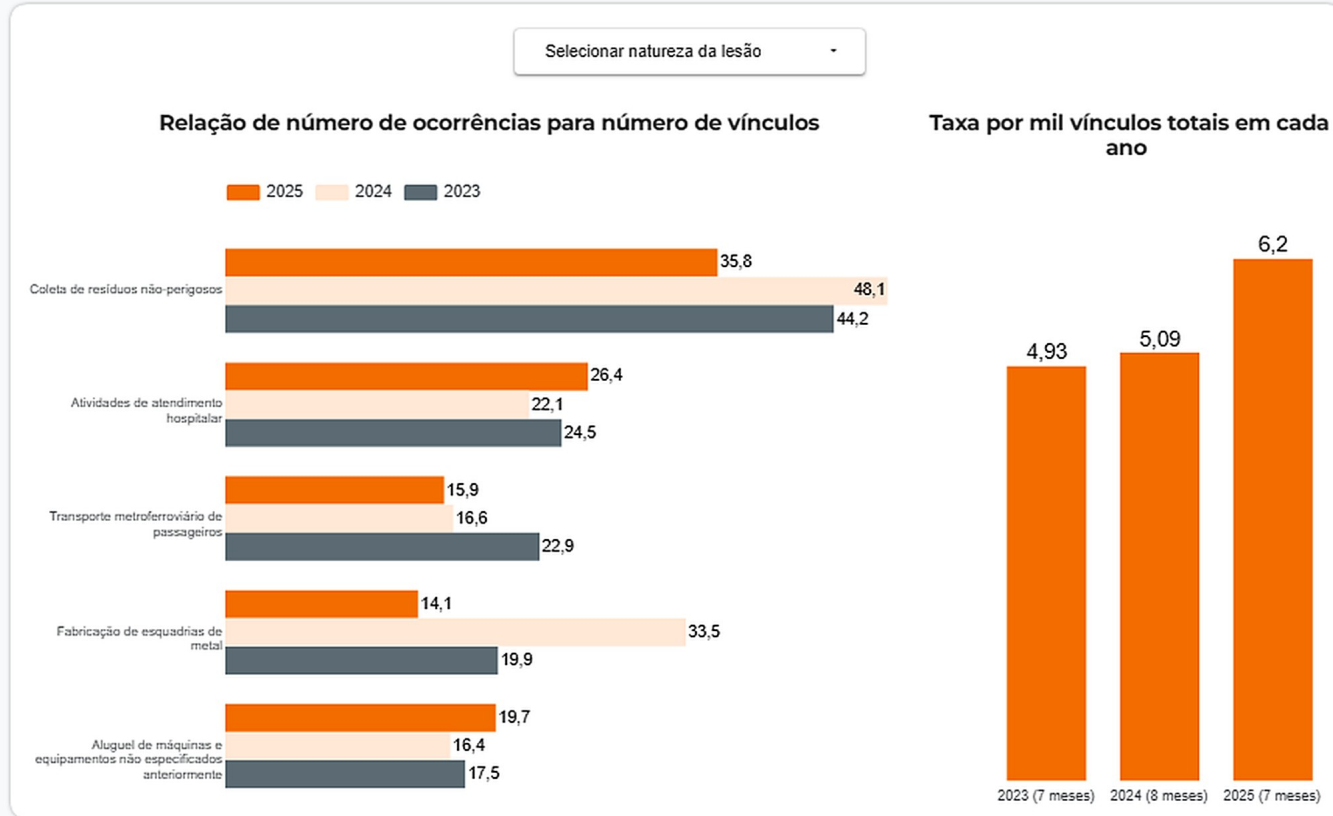
O dashboard respondendo às perguntas
da gestão.



QUESTÃO 1 · SETORES (CNAE)

Coleta de resíduos e hospitais lideram o risco de acidente de trabalho no Recife.

Observatório de Saúde do Trabalhador - Recife: Setores

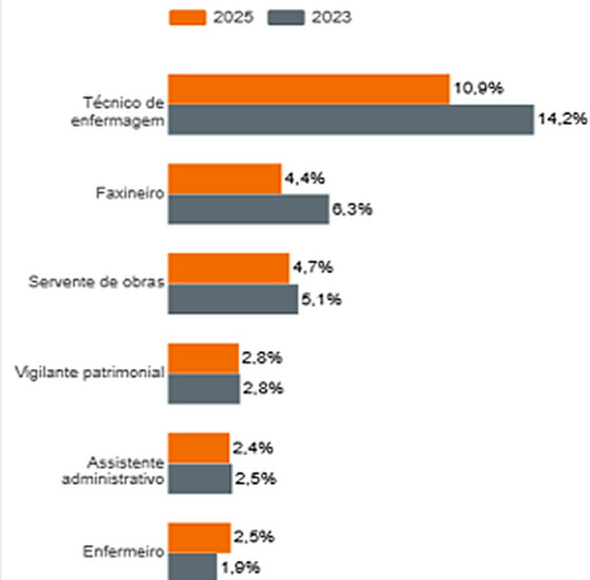


QUESTÃO 2 · OCUPAÇÕES (CBO) E DIAGNÓSTICOS (CID-10)

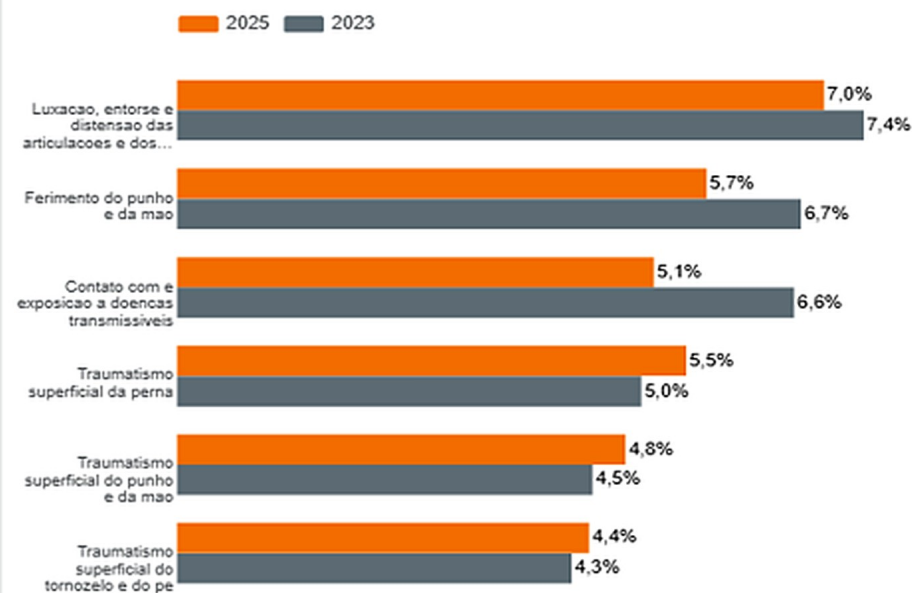
Apesar da queda, enfermagem e obras concentram as CATs, assim como luxação e ferimentos no punho.

Observatório de Saúde do Trabalhador - Recife: Ocupações e Diagnósticos

Participação de CBO por ano



Participação de CID-10 por ano



QUESTÃO 3 · SUBNOTIFICAÇÃO

Invisibilidade estatística: vários setores registram bem menos acidentes que o esperado.

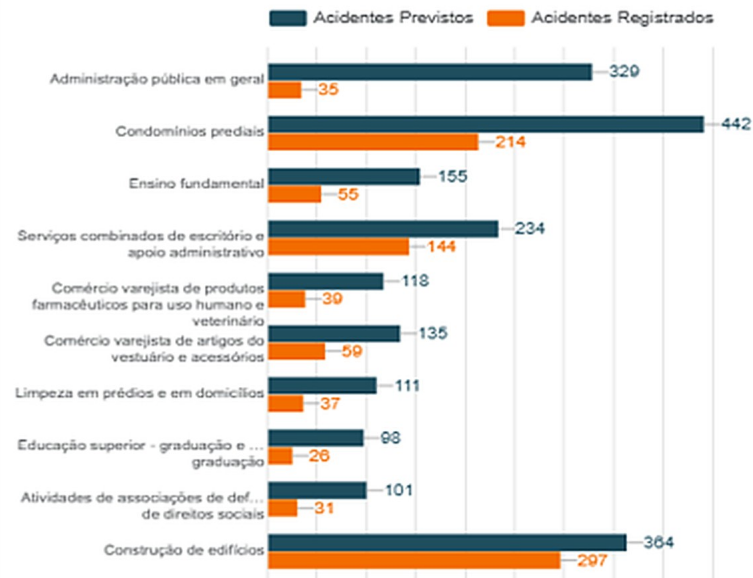
Observatório de Saúde do Trabalhador - Recife: Sinais de Subnotificação

Acidentes Totais
10.677

CATs em setor sem vínculo na RAIS
0

Percentual
0

Acidentes previstos e registrados por atividade econômica



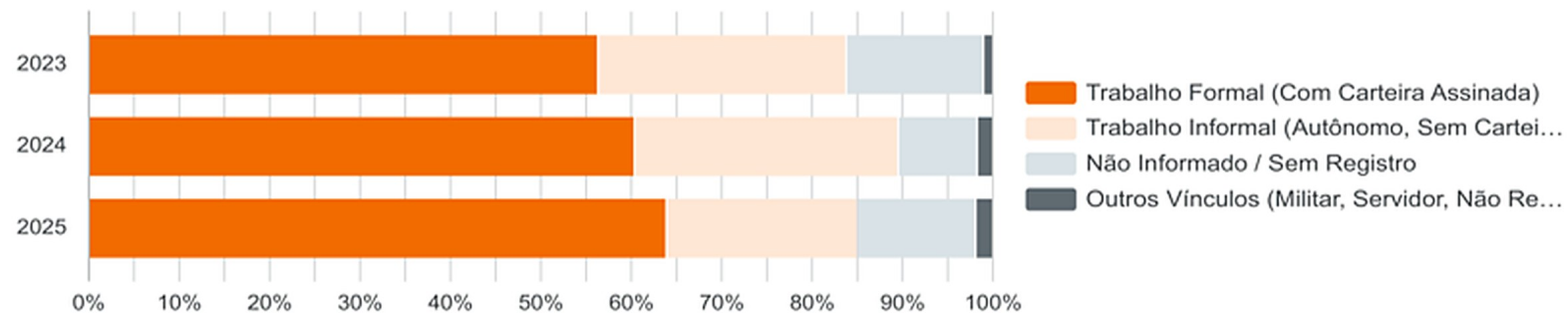
Cargo	Razão Observado Esper...	Diferença do regi...
Administração pública em geral	11%	294
Condomínios prediais	48%	228
Ensino fundamental	36%	100
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	62%	90
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	33%	79
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	44%	76
Limpeza em prédios e em domicílios	33%	74
Educação superior - graduação e pós-graduação	27%	72
Atividades de associações de defesa de direitos sociais	31%	70
Construção de edifícios	82%	67

QUESTÃO 4 · REDE DE SAÚDE × TRABALHADOR

**Trabalho formal dita a busca por atendimento,
mas a informalidade já passa de um quarto dos casos.**

Observatório de Saúde do Trabalhador - Recife: Rede de Saúde

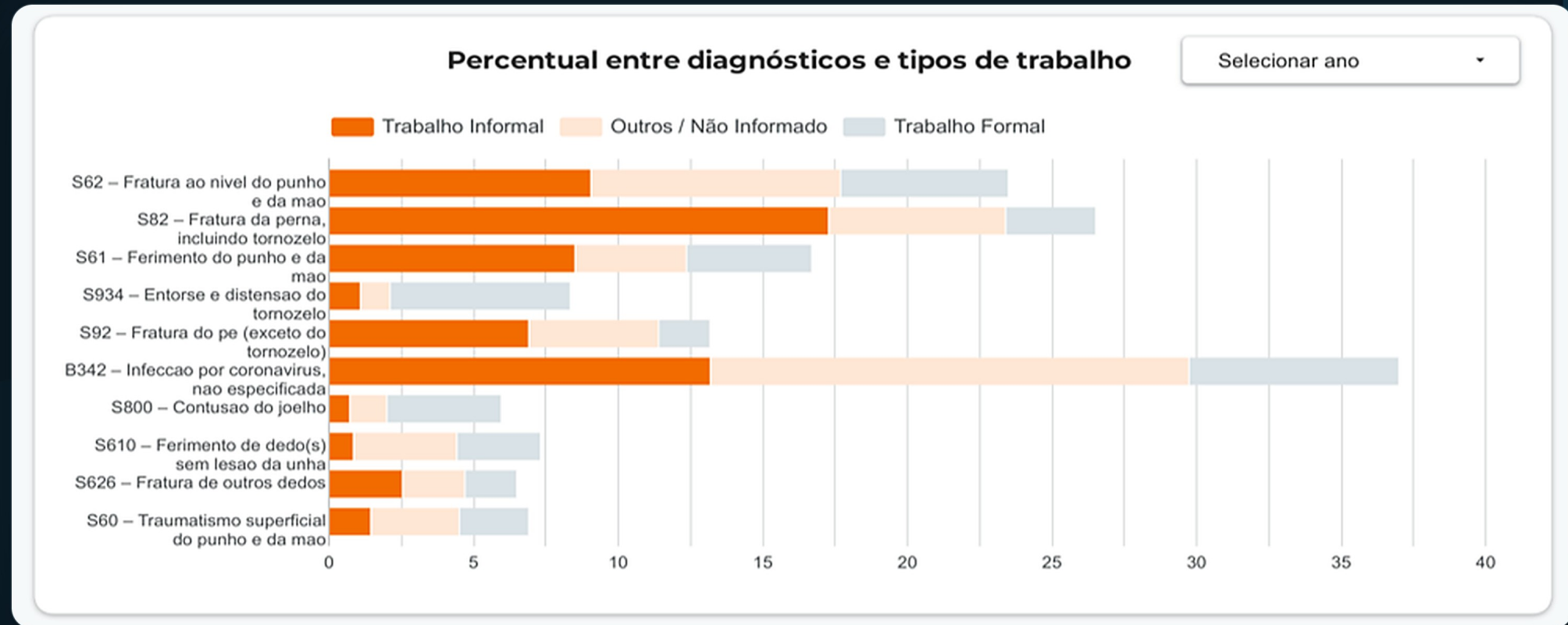
Percentual entre total de acidentes e tipos de trabalho



QUESTÃO 4 · REDE DE SAÚDE × TRABALHADOR

Mapeamento CID: trabalho formal × informal.

Formal: membros superiores · Informal: membros inferiores



FECHAMENTO · CONCLUSÃO

Parte do risco está visível, parte está oculta.

1

Risco visível: coleta e hospitais

Coleta de resíduos lidera em taxa (35,8); hospitais vêm a seguir (26,4).

2

Enfermagem e traumas lideram

Técnico de enfermagem concentra as CATs (10,9%), com entorses e luxações.

3

Risco oculto: apagão de CATs

Administração pública registrou só 35 de 329 CATs esperadas (11%).

4

Impacto no SUS e informalidade

Trabalho informal: 25,89% dos acidentes graves e fraturas severas (CID S82).

PRÓXIMOS PASSOS



Fiscalização direcionada

Ações preventivas em canteiros de obras e hospitais críticos.



Combate à subnotificação

Exigir CAT na administração pública e nos condomínios.



Qualificação no SUS

Treinar triagens para reduzir ocupações omissas (12%) no SINAN.

Perguntas?
